

Κριτήρια αξιολόγησης της Οξείας Παγκρεατίτιδας

Η **αναθεωρημένη ταξινόμηση της Ατλάντα του 2012** αποτελεί επικαιροποίηση της αρχικής ταξινόμησης της Ατλάντα του 1992, μια τυποποιημένη κλινική και ακτινολογική περιγραφή για την οξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ) και τις σχετικές επιπλοκές με βάση την πρόοδο των ερευνών που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΟΠ χωρίζεται πλέον σε δύο διακριτούς κλινικούς υποτύπους, την **ήπια διάμεση οίδηματώδη παγκρεατίτιδα** (1) και τη **νεκρωτική παγκρεατίτιδα** (2), με βάση την παρουσία ή την απουσία νέκρωσης, αντίστοιχα.

Στάδιο	Χαρακτηριστικό	Κριτήριο αξιολόγησης
1	Ήπια	Απουσία οργανικής ανεπάρκειας Απουσία τοπικών ή συστηματικών επιπλοκών
	Μετρίως σοβαρή	Παροδική ανεπάρκεια οργάνων (<48 ώρες) και/ή τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές ή επιδείνωση συννοσηροτήτων
2	Σοβαρή	Εμμένουσα οργανική ανεπάρκεια (> 48 ώρες, οξεία αναπνευστικής δυσχέρεια / οξεία νεφρική βλάβη/οξεία διαταραχή πήξης)
		Σοβαρή: Επιμολυσμένη περιπαγκρεατική νέκρωση ή οργανική ανεπάρκεια > 48 ώρες. Κριτική: Επιμολυσμένη περιπαγκρεατική νέκρωση & οργανική ανεπάρκεια > 48 ώρες.

Άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες κλινικές βαθμολογίες - προγνωστικές της βαρύτητας της ΟΠ - περιλαμβάνουν: τα κριτήρια Ranson, τα προγνωστικά κριτήρια της Γλασκώβης (Glasgow - Imrie Score), το Japanese Severity Score, το Harmless Acute Pancreatitis Score, το Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP) score, το σύστημα APACHE II, το σύστημα βαθμολόγησης Balthazar ενισχυμένο με αξονική τομογραφία (CT), κ.λπ.

Τα κριτήρια του Ranson είναι από τα πλέον πρώιμα συστήματα βαθμολόγησης για την κλινική αξιολόγηση της βαρύτητας της ΟΠ και συνεχίζουν - μέχρι και τις ημέρες μας - να χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Από τότε, τουλάχιστον άλλα 17 κλινικά συστήματα βαθμολόγησης έχουν αναπτυχθεί. Για τα κριτήρια Ranson λοιπόν ισχύουν τα παρακάτω:

Κριτήρια Ranson (αλκοολικής ή άλλης αιτίας)	Κριτήρια Ranson (λιθιασικής αιτιολογίας)
Κατά την άφιξη στο ΤΕΠ	Κατά την άφιξη στο ΤΕΠ
• Ηλικία > 55 έτη • WBC > 16000 / mm³ • LDH > 350 U/L • AST (SGOT) > 250 U/L • Γλυκόζη ορού > 200 mg/dl	▪ Ηλικία > 70 έτη ▪ WBC > 18000 / mm³ ▪ LDH > 400 U/L ▪ AST (SGOT) > 250 U/L ▪ Γλυκόζη ορού > 220 mg/dl
Μετά το πρώτο 48ωρο νοσηλείας	Μετά το πρώτο 48ωρο νοσηλείας
• Πτώση του Hct > 10% • Αύξηση ουρίας > 11 mg/dl ή BUN > 5 mg/dl • Ασβέστιο < 8 mg/dl • PO₂ < 60 mmHg • Έλλειμα Βάσης > 4 mEq/l • Απώλεια υγρών > 6 lt	▪ Πτώση του Hct > 10% ▪ Αύξηση ουρίας > 4,3 mg/dl ή BUN > 2 mg/dl ▪ Ασβέστιο < 8 mg/dl ▪ PO₂ < 60 mmHg ▪ Έλλειμα Βάσης > 5 mEq/l ▪ Απώλεια υγρών > 4 lt
Κάθε κριτήριο λαμβάνει έναν (1) βαθμό (σύνολο: 0 έως 11). ➤ 0 έως 2 βαθμοί: Η σοβαρή ΟΠ είναι απίθανη → Θνητότητα: 0% - 3% ➤ 3 έως 4 βαθμοί: Η σοβαρή ΟΠ είναι πιθανή → Θνητότητα: 15% ➤ 5 έως 6 βαθμοί: Η σοβαρή ΟΠ είναι αρκετά πιθανή → Θνητότητα: 40% ➤ 7 έως 11 βαθμοί: Η σοβαρή ΟΠ είναι πολύ πιθανή → Θνητότητα: 100%	